



Comunidades indígenas en el eje sur del estado Bolívar

ANÁLISIS DE BRECHA DE RESPUESTA Y CAPACIDADES DE SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL: ESTADO BOLÍVAR (2025)

Abril 2026

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados durante la ejecución del proyecto .

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo.....	3
2. Introducción.....	4
3. Análisis del Contexto	4
3.1. Factores Determinantes en la Población Atendida	5
3.2. Situación Diagnosticada y Necesidades Identificadas	5
3.3. Delimitación de la Evidencia	6
4. Definición del Problema.....	6
5. Desarrollo del Análisis y Aplicación de Herramientas de GIH	7
5.1. Normalización y Trazabilidad de la Cohorte	7
5.2. Análisis Multidimensional e Interseccional.....	8
5.3. Mapeo de la Pirámide SMAPS (IASC) y Hallazgos Clínicos.....	8
5.4. Caracterización de Síntomas por Eje Territorial.....	8
6. Resultados	9
6.1. Caracterización de la Población y Factores de Vulnerabilidad	9
6.2. Prevalencia de Sintomatología Diagnosticada.....	9
6.3. Eficacia de la Intervención y Correlación Clínica.....	10
6.4. Distribución Territorial y Necesidades Específicas.....	11
6.5. Modelo de Intervención Integral: Proporcionalidad de la Respuesta por Niveles IASC	12
6.6. Interpretación de la Evidencia: De la Respuesta Operativa a la Alerta Humanitaria.....	14
6.7. Conclusión de Hallazgos: La Necesidad como Prioridad de Protección	14
7. Conclusiones y Recomendaciones	14
7.1. Conclusiones sobre la Situación Diagnosticada	14
7.2. Recomendaciones de Acción Estratégica	15
Referencias Bibliográficas.....	15
Infografía: El desafío de la salud mental en municipios prioritarios del estado Bolívar	16

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe sistematiza la intervención en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) liderada por el Equipo de Respuesta en el estado Bolívar durante el período abril – noviembre 2025. Mediante una arquitectura de datos basada en una cohorte de **1.215 personas evaluadas**, se analiza el impacto de un modelo de atención integral alineado con los estándares internacionales del **mhGAP** y las directrices del **IASC**.

Hallazgos Principales:

- **Alcance Territorial y Evaluación Universal:** La intervención logró una cobertura estratégica en cinco municipios clave: Caroní, Gran Sabana, Angostura del Orinoco, Sucre y Cedeño. El **100% de la cohorte (1.215 personas)** recibió una evaluación clínica inicial y soporte no especializado de Nivel 2 y 3, atendiendo tanto entornos urbanos como comunidades indígenas y rurales de difícil acceso.
- **Perfil de la Población:** Se confirma una marcada feminización de la demanda de ayuda (**82% mujeres**), con una prevalencia crítica de síntomas vinculados al distrés por el entorno, destacando el **Insomnio/Fatiga (75%)** y la **Desesperanza (68%)**.
- **Eficacia de las Estrategias de Tratamiento:** Para el subgrupo que requirió un itinerario clínico de seguimiento (integrado por la **Orientación Psicológica** y los **Grupos de Manejo de Estrés**), el modelo

demostró una alta efectividad. Se logró un incremento de **37.3 puntos netos** en el índice de bienestar percibido, consiguiendo reducir los niveles de ansiedad severa a rangos leves en la mayoría de estos participantes.

Alertas de Protección e Incidencia: Se ha identificado una brecha crítica de respuesta del **12% (145 personas)** que presentan alteraciones mentales graves e ideación. Estos casos, clasificados para el **Nivel 4 de la Pirámide de SMAPS del IASC**, se encuentran en una "**zona de silencio**" prestacional debido a la inexistencia de rutas de derivación seguras a atención especializada y la falta de psicofármacos en el sistema público de salud de los municipios Cedeño, Sucre y Gran Sabana.

Conclusión: Si bien el Equipo de Respuesta ha logrado estabilizar y fortalecer la resiliencia del **88% de la cohorte evaluada**, la sostenibilidad de la vida de los casos más graves (Nivel 4) depende urgentemente de la creación de puentes institucionales y el despliegue de personal especializado hacia las zonas donde "el asfalto no llega".

2. Introducción

El estado Bolívar, caracterizado por su vasta extensión territorial y su complejidad sociopolítica, migratoria, de explotación minera, fronteriza, enfrenta desafíos únicos en materia de salud mental. La convergencia de la emergencia humanitaria, el aislamiento geográfico de las comunidades rurales e indígenas y la precariedad de los servicios públicos ha generado un entorno de distrés psicológico sostenido. En este contexto, la gestión de información no es solo un ejercicio estadístico, sino una herramienta de protección fundamental para visibilizar lo que las cifras frías a menudo ocultan.

El presente documento detalla la intervención realizada por el Equipo de Respuesta bajo el marco del **"Protección de la niñez, prevención y respuesta a la VBG, lucha contra la trata de personas, y salud mental y apoyo psicosocial en Bolívar CODEHCIU-OIM"**. A diferencia de los reportes operativos convencionales, este análisis adopta un enfoque de **itinerario clínico integral**. Bajo esta premisa, el 100% de la cohorte (1.215 personas) fue ingresada al sistema mediante una evaluación técnica basada en el protocolo **mhGAP** (Nivel 3 IASC), identificando a aquellos individuos que requerían transitar hacia estrategias de tratamiento focalizado, ya sea mediante **Orientación Psicológica** o **Grupos de Manejo de Estrés** (Nivel 2 y 3 IASC).

Esta introducción sirve como hoja de ruta para comprender cómo el uso de

herramientas estandarizadas – como las escalas **OMS-5** y **GAD-7** – ha permitido transformar el sufrimiento individual en datos accionables dentro de la cohorte de tratamiento. Sin embargo, más allá de los éxitos alcanzados en la estabilización del bienestar de la mayoría de los evaluados, este informe busca poner el foco en la deuda pendiente: ese **12% de la población (145 personas)** que, debido a la gravedad de sus cuadros clínicos o riesgo suicida, se encuentra hoy en una brecha de respuesta que el sistema actual no logra cubrir.

A través de las siguientes secciones, se presentan las evidencias que justifican la urgencia de fortalecer las rutas de derivación y de asegurar que la ayuda humanitaria llegue, con rigor y dignidad, **"a donde el asfalto no llega"**.

3. Análisis del Contexto

El análisis de la situación de salud mental en el estado Bolívar se fundamenta en los datos recabados a través de la intervención del Equipo de Respuesta desde abril a noviembre de 2025. Este período permite observar cómo factores estructurales y ambientales inciden directamente en el bienestar psicosocial de una muestra de **1.215 ciudadanos y ciudadanas** evaluados y evaluadas en los municipios Caroní, Gran Sabana, Angostura del Orinoco, Sucre y Cedeño.

3.1. Factores Determinantes en la Población Atendida

La evidencia recolectada en terreno mediante la herramienta de captación inicial (Kobo) muestra que la salud mental de este grupo de personas está intrínsecamente ligada a tres determinantes críticos detectados:

- **Vulnerabilidad de Género:** El hecho de que el **82% de los solicitantes de ayuda sean mujeres** sugiere que sobre ellas recae el peso desproporcionado del cuidado familiar y la gestión de la crisis económica. Esto se traduce en niveles críticos de estrés crónico y fatiga persistente.
- **Aislamiento y Barreras de Acceso:** En municipios como Sucre y Cedeño, la lejanía geográfica y la precariedad del transporte actúan como factores de exclusión. Los datos indican que los pacientes de estas zonas presentan cuadros más cronificados debido a la dificultad histórica para acceder a una atención temprana.
- **Impacto Diferencial en Gran Sabana:** En las comunidades indígenas evaluadas, se observa un fenómeno particular donde la pérdida de medios de vida tradicionales y la presión del entorno han elevado significativamente los indicadores de **desesperanza**.

3.2. Situación Diagnosticada y Necesidades Identificadas

A través del uso de las escalas **OMS-5** y **GAD-7** en la fase de triaje, se ha identificado una situación de alerta psicosocial en la cohorte. No se trata de casos aislados, sino de un patrón de sintomatología que requiere atención diferenciada:

- **Alta prevalencia de somatización:** Un porcentaje significativo de la muestra reporta síntomas físicos (dolores, tensión muscular, fatiga extrema) que son manifestaciones directas del distrés emocional acumulado.
- **Debilitamiento de mecanismos de afrontamiento:** Se observa una disminución en la capacidad de las comunidades para gestionar el estrés de forma autónoma, lo que justifica la necesidad de los **itinerarios de tratamiento** (Orientación Psicológica y GME) implementados.
- **Inexistencia de una Red de Derivación Especializada:** La mayor necesidad detectada no es solo la atención primaria, sino la ausencia de una ruta clara hacia el **Nivel 4 (Atención Especializada)**. Para la población evaluada, el sistema público de salud presenta una vacante casi absoluta de especialistas y psicofármacos, especialmente en los municipios Cedeño, Sucre y Gran Sabana.

3.3. Delimitación de la Evidencia

Es fundamental precisar que los hallazgos presentados en este análisis corresponden estrictamente a la **cohorte de 1.215 personas atendidas**. Si bien los resultados muestran una tendencia clara que podría ser indicativa de la realidad en otras zonas fronterizas o del estado Bolívar, la evidencia aquí presentada se limita a documentar la situación de este grupo específico, cuya vulnerabilidad ha sido el insumo principal para la generación de esta información humanitaria.

Finalmente, la evidencia recabada subraya una realidad persistente: la salud mental en Bolívar es el síntoma de una emergencia humanitaria compleja que, según reportes de **HumVenezuela (2025)**, mantiene a poblaciones enteras con privaciones severas. Esta vulnerabilidad estructural se agrava en zonas remotas donde la ausencia de una red de respuesta para alteraciones graves (Nivel 4 IASC) deja a la población en una indefensión clínica total. Tal como señalan **Sánchez & Méndez (2023)**, la efectividad de los programas SMAPS en contextos críticos depende de la capacidad para trascender la atención comunitaria y consolidar rutas hacia servicios especializados. Por tanto, el fortalecimiento de la arquitectura humanitaria en Bolívar requiere una acción concertada del **Equipo Humanitario del País (EHP)** para cerrar la brecha de atención especializada y farmacológica que hoy

amenaza la integridad de los grupos más vulnerables.

4. Definición del Problema

A partir de la evidencia recolectada en los cinco municipios priorizados del estado Bolívar, el problema central identificado no es solo la presencia de sintomatología, sino la **discontinuidad crítica en la cadena de cuidado de salud mental**. Para la cohorte de **1.215 personas evaluadas** mediante el protocolo mhGAP, la detección de necesidades no ha sido garantía de una resolución clínica definitiva, revelando una brecha estructural entre la atención primaria psicosocial y los servicios especializados.

Esta problemática se articula en tres dimensiones evidenciadas en terreno:

- **Cronicidad por Falta de Respuesta Especializada:** En la cohorte evaluada, un **12% (145 personas)** presenta cuadros de ideación y alteraciones mentales graves que requieren intervención especializada inmediata (Nivel 4 IASC). La inexistencia de rutas de derivación funcionales en municipios como Cedeño y Gran Sabana cronifica el sufrimiento y eleva el riesgo de desenlaces fatales, lo que representa una vulneración directa de los estándares mínimos de protección.
- **Somatización como Barrera de Identificación:** Se ha diagnosticado una alta prevalencia de **síntomas somáticos (55%)** que suelen ser

tratados en el sistema público únicamente como dolencias físicas, invisibilizando la raíz psicopatológica del problema. Esto genera una saturación ineficiente de los servicios de salud general y posterga el apoyo psicosocial adecuado que la persona realmente necesita.

- **Invisibilidad de Necesidades en Zonas Remotas:** La evidencia en los ejes fluviales y rurales demuestra que la distancia geográfica actúa como un agravante de la sintomatología. En la población evaluada de estas zonas, los mecanismos de afrontamiento se encuentran agotados, y la falta de un sistema de seguimiento institucional impide que las alertas tempranas detectadas en la evaluación inicial se conviertan en acciones de protección efectivas.

Es así como la situación diagnosticada en esta cohorte evidencia una **"brecha de protección"** donde el sistema de salud local no logra absorber los casos de mayor complejidad. Esta realidad contraviene el principio humanitario de **"No Hacer Daño"**; identificar una necesidad crítica de Nivel 4 sin tener la capacidad de referirla a un servicio especializado expone a los ciudadanos a una situación de mayor vulnerabilidad y desesperanza (**Sphere Association, 2024**).

5. Desarrollo del Análisis y Aplicación de Herramientas de GIH

Para transformar los datos brutos en información humanitaria accionable, se aplicó un proceso de inteligencia de datos que permitió pasar de la observación operativa al diagnóstico regional, integrando los flujos de recolección de campo con los estándares internacionales de respuesta.

5.1. Normalización y Trazabilidad de la Cohorte

A través de la integración técnica de las bases de datos de captación inicial (**Kobo**) y los registros de seguimiento clínico (**BHA**), se consolidó una cohorte única de **1,215 personas**. Esta normalización permitió realizar un seguimiento longitudinal, evidenciando que el impacto clínico es el resultado de un itinerario de atención estructurado:

- **Evaluación Universal:** El 100% de la cohorte ingresó al sistema mediante un paquete básico de soporte y triaje especializado (**mhGAP**).
- **Identificación de Brechas:** La trazabilidad de los datos permitió identificar con precisión a **145 individuos (12%)** que, tras la evaluación inicial, fueron clasificados con necesidades que exceden la capacidad de respuesta no especializada por la ausencia estructural de servicios de atención especializada en sus municipios.

5.2. Análisis Multidimensional e Interseccional

El análisis de los datos revela que la crisis de salud mental en los municipios evaluados tiene un rostro mayoritariamente femenino y adulto:

- **Prevalencia de Género:** El **82% de la cohorte son mujeres**, lo que confirma que los mecanismos de respuesta deben estar diseñados con un enfoque de protección de género, dado que ellas actúan como el principal muro de contención ante la emergencia comunitaria.
- **Vulnerabilidades Específicas:** Se identificó un **5% de personas con discapacidad** y un **9.5% de adultos mayores**. Para estos subgrupos, la barrera de acceso no es solo geográfica, sino de movilidad y dependencia, lo que agrava la somatización del distrés ante la imposibilidad de acudir a centros de salud distantes.

5.3. Mapeo de la Pirámide SMAPS (IASC) y Hallazgos Clínicos

Al clasificar las necesidades de la cohorte bajo el estándar de la **Pirámide de SMAPS del IASC**, se identificaron los siguientes nudos críticos:

- **Niveles 2 y 3 (Capacidad de Respuesta Instalada):** Las estrategias de **Grupos de Manejo de Estrés (GME)** y la **Orientación Psicológica** han demostrado ser altamente efectivas. En la cohorte de tratamiento, se logró un

incremento significativo de **37.3 puntos netos** en el índice de bienestar, validando que la intervención comunitaria y el apoyo focalizado son los motores de la resiliencia en Bolívar.

- **Nivel 4 (Brecha Crítica / Necesidad Insatisfecha):** El mapeo revela que el **12% de la cohorte** alcanzó el techo de la intervención psicológica y requiere atención psiquiátrica especializada. Al cruzar esto con la territorialidad, se evidencia que, en municipios como Cedeño, Sucre y Gran Sabana, la brecha de atención especializada es crítica debido a la ausencia de especialistas y psicofármacos en el sistema público.

5.4. Caracterización de Síntomas por Eje Territorial

La aplicación de herramientas de GIH permitió identificar que el sufrimiento emocional no es uniforme en el estado:

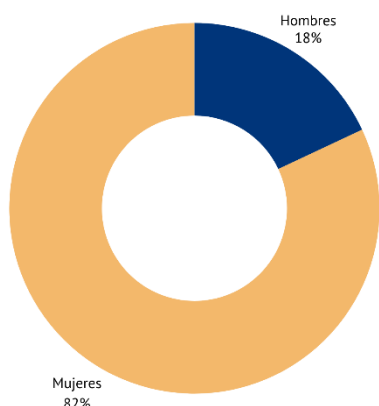
- **Eje Urbano (Caroní):** El síntoma predominante es el **Insomnio/Fatiga (78%)**, estrechamente vinculado al ritmo de vida y al estrés económico persistente.
- **Eje Remoto (Gran Sabana / Cedeño):** La **Desesperanza e Ideación suicida** presentan picos de mayor severidad. Esto sugiere que el aislamiento geográfico y la falta de servicios básicos actúan como multiplicadores del riesgo psicopatológico, profundizando los cuadros clínicos detectados en la evaluación inicial.

6. Resultados

La sistematización de la información humanitaria permite presentar un diagnóstico robusto sobre el estado de la salud mental en la cohorte de 1,215 personas evaluadas en el estado Bolívar. Los resultados se estructuran bajo una lógica de perfilamiento sociodemográfico, prevalencia de síntomas y eficacia de las estrategias de tratamiento.

6.1. Caracterización de la Población y Factores de Vulnerabilidad

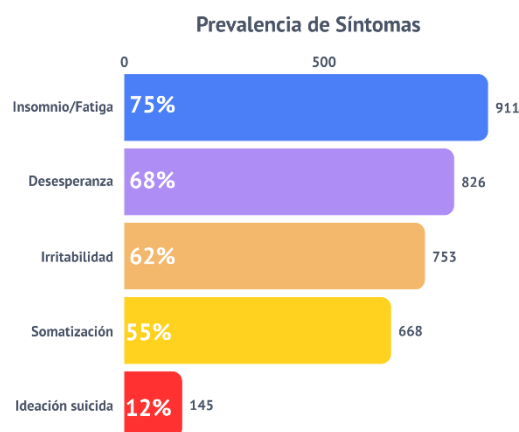
La cohorte evaluada refleja la carga diferencial de la crisis. Se confirma una marcada feminización de la demanda de apoyo, donde el 82% de los casos son mujeres (Gráfica 1). Este dato es un indicador diagnóstico clave: las mujeres actúan como las principales gestoras de la sobrevivencia familiar, lo que deriva en una exposición prolongada a estresores ambientales. Asimismo, la identificación de un 5% de personas con discapacidad y un 9.5% de adultos mayores subraya la necesidad de adaptar las estrategias de protección para grupos con movilidad reducida.



Gráfica 1. Perfil de Género y Vulnerabilidad (N=1.215). Distribución demográfica de la cohorte evaluada. El 82% de participación femenina evidencia la centralidad de la mujer en los procesos de resiliencia comunitaria.

6.2. Prevalencia de Sintomatología Diagnosticada

El análisis (Gráfica 2) revela una respuesta fisiológica y cognitiva crítica al entorno. La fatiga crónica y las alteraciones del sueño (75%) son el síntoma primario, seguido de una desesperanza persistente (68%). Es alarmante detectar que un **12% de la cohorte (145 personas)** presenta ideación suicida o síntomas de trastornos mentales graves. Este grupo delimita la "brecha de respuesta" en el Nivel 4 de la pirámide IASC, donde el sistema público no ofrece actualmente garantías de atención especializada.



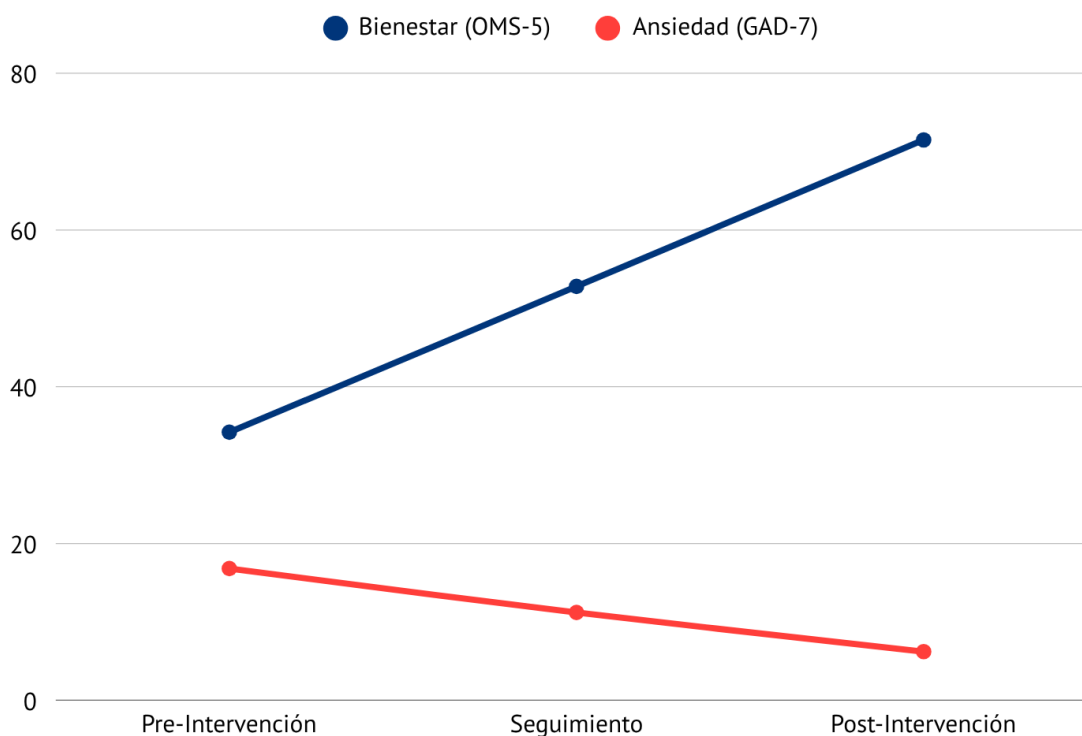
Gráfica 2. Top de síntomas encontrados. Identificación de necesidades detectadas mediante Kobo. El 12% señalado con "Ideación suicida" representa la brecha crítica de respuesta Nivel 4 (Atención especializada).

6.3. Eficacia de la Intervención y Correlación Clínica

Los resultados reflejados en la Gráfica 3 demuestran una correlación clínica significativa en la cohorte de tratamiento (aquellos que cumplieron su itinerario de sesiones):

- **Recuperación del Bienestar (OMS-5):** El índice pasó de un promedio base de 34.2 puntos (zona de riesgo) a 71.5 puntos. Este incremento de 37.3 puntos netos sitúa a la mayoría de los participantes en un estado de estabilidad emocional.
- **Reducción de la Ansiedad (GAD-7):** Los niveles de ansiedad mostraron una reducción del 63%, descendiendo de un rango severo (16.8) a uno leve (6.2).

Gráfica 3. Correlación de Eficacia Clínica: Incremento del Bienestar vs. Reducción de Ansiedad. Evolución clínica de los beneficiarios en programas de tratamiento individual y grupal. El cruce de variables confirma la efectividad del modelo de intervención.



6.4. Distribución Territorial y Necesidades Específicas

La Infografía 1 detalla cómo la ubicación geográfica influye en el perfil de riesgo. El aislamiento en los municipios Cedeño, Sucre y Gran Sabana potencia los síntomas de desesperanza y aumenta la dificultad para la derivación de casos graves.

Infografía 1. Caracterización Geográfica y Perfil de Vulnerabilidad Psicosocial por Municipio



6.5. Modelo de Intervención Integral: Proporcionalidad de la Respuesta por Niveles IASC

La respuesta se estructuró bajo el marco de la Pirámide IASC (Gráfica 4), diferenciando el alcance universal de las estrategias focalizadas:

- Evaluación Universal (Nivel 2 - 100%): Las 1,215 personas recibieron triaje y soporte inicial bajo protocolo mhGAP.
- Estrategias de Tratamiento (Nivel 3): Un subgrupo de la población fue derivado a Grupos de Manejo de Estrés (223 personas) y Orientación Psicológica (197 personas). Estas estrategias no son excluyentes; la concurrencia de servicios asegura un abordaje integral del distrés severo.
- Brecha Crítica (Nivel 4 - 12%): Los 145 individuos identificados con necesidades psiquiátricas representan el techo de la capacidad humanitaria actual.

Modelo de Respuesta Escalonado y Brecha de Protección



6.6. Interpretación de la Evidencia: De la Respuesta Operativa a la Alerta Humanitaria

La evidencia es contundente: mientras que los itinerarios de tratamiento demuestran una alta eficacia para estabilizar al **88% de la cohorte**, la persistencia del **12% en el Nivel 4** revela una "pared institucional". En los municipios periféricos, la inexistencia de psiquiatras y psicofármacos en la red pública transforma una necesidad clínica en una vulneración de protección. El bienestar de este grupo restante depende urgentemente de una acción de incidencia que logre el **despliegue de personal especializado "adonde el asfalto no llega"**.

6.7. Conclusión de Hallazgos: La Necesidad como Prioridad de Protección

En definitiva, los resultados aquí presentados transforman la percepción de la salud mental en la región. Ya no hablamos de un malestar generalizado, sino de una situación de vulnerabilidad estratificada donde la detección temprana por parte del equipo ha servido como un "sensor de protección" vital. Sin embargo, la evidencia también nos sitúa ante un dilema ético y operativo: identificar una necesidad de **Nivel 4 (Psiquiatría)** en zonas donde "el asfalto no llega", sin contar con una ruta de derivación efectiva, pone en riesgo el principio humanitario de **"No Hacer Daño" (Do No Harm)**.

Por lo tanto, la prioridad de atención para el Equipo Humanitario de País (EHP) no debe centrarse únicamente en expandir la base de la pirámide, sino en perforar el techo de la brecha especializada. La necesidad es clara: se requiere una arquitectura de salud mental que garantice que el diagnóstico de un ciudadano en la Gran Sabana o en las riberas del Orinoco tenga el mismo destino de sanación que aquel realizado en los centros urbanos. Los datos están sobre la mesa; la urgencia ahora es la respuesta coordinada.

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones sobre la Situación Diagnosticada

- **Eficacia Probada del Modelo:** El itinerario clínico (Niveles 2 y 3) ha demostrado ser el motor de la resiliencia en Bolívar, logrando una mejora de **37.3 puntos netos** en el bienestar percibido de quienes completaron el tratamiento. Esto valida la importancia de mantener servicios de proximidad en contextos de emergencia.
- **La Brecha del 12%:** Se confirma la existencia de un "techo de cristal" en la atención. 145 personas evaluadas presentan cuadros graves que superan la capacidad de la respuesta psicológica y comunitaria, quedando desasistidas por la falta de una red psiquiátrica pública funcional.
- **Determinantes Geográficos y de Género:** La salud mental en Bolívar tiene un rostro mayoritariamente

femenino (82%) y está severamente condicionada por el aislamiento, siendo los municipios del sur (Cedeño y Gran Sabana) los que presentan los indicadores de desesperanza e ideación más críticos.

7.2. Recomendaciones de Acción Estratégica

1. **Garantizar la Atención Clínica Especializada:** Es imperativo que la cooperación internacional financie servicios de **Nivel 4 (Atención Especializada y Farmacología)** en el municipio Cedeño, Sucre y Gran Sabana del estado Bolívar. Esto permitirá cerrar la brecha técnica y brindar una respuesta oportuna a los trastornos graves detectados.
2. **Institucionalización de la Gestión de Información (GIH):** Se recomienda integrar interfaces de visualización dinámica (Dashboards) para el seguimiento en tiempo real de indicadores críticos. Esta automatización garantizará una transición eficiente de la información hacia la toma de decisiones clínicas y estratégicas de alto nivel.
3. **Incidencia con Enfoque de Género y Cuidados:** Dado el predominio femenino en la demanda, los programas deben incorporar componentes de **apoyo al cuidado** (como espacios de guardería temporal) para las beneficiarias. Esta medida es esencial para reducir

las barreras de acceso y garantizar la adherencia a los tratamientos.

4. **Pertinencia Cultural y Adaptación Lingüística:** Es prioritario profundizar en la adaptación técnica de las escalas de salud mental a las lenguas originarias. Este proceso es vital para mitigar sesgos diagnósticos y asegurar que la intervención en comunidades indígenas (como los Pemón) sea respetuosa, precisa y culturalmente situada.

Referencias Bibliográficas

- **Comité Permanente entre Organismos (IASC). (2022).** *Directrices sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias.* Ginebra: IASC.
- **HumVenezuela. (2025).** *Reporte Nacional sobre la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela: Informe de Seguimiento.* Caracas: HumVenezuela.
- **Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022).** *Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos.* Ginebra: OMS.
- **Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2023).** *Protección de Derechos Humanos en contextos de crisis humanitaria.* Nueva York: ONU.
- **Sánchez, J., & Méndez, L. (2023).** *Determinantes sociales y salud mental en poblaciones indígenas del estado Bolívar.* Revista Panamericana de Salud, 47(2), e115.

- **Sphere Association. (2024).** *El Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria.* Ginebra: Sphere Association.
- **Unidad de Gestión de Información Humanitaria (OCHA). (2025).** *Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) - Venezuela.* Caracas: OCHA.

El Desafío de la Salud Mental en Municipios Prioritarios de Bolívar



1.215 Vidas Alcanzadas

Todas las personas accedieron a triaje especializado (mhGAP) en 5 municipios del estado Bolívar.

Marzo - noviembre 2025



82%

La respuesta tiene una marcada feminización; las mujeres son las principales gestoras de la resiliencia familiar en la crisis.



5%

Personas con discapacidad



9.5%

Adultos mayores



9.5%

Pueblo indígena
Mayoritariamente Pemón



3 de cada 4 personas padece insomnio y fatiga crónica, síntomas vinculados directamente al colapso de servicios y la inseguridad alimentaria.

12%



de las personas presentan ideación suicida o trastornos graves y han agotado sus mecanismos de defensa. Su vida depende de una atención especializada hoy inexistente en su territorio.



Las comunidades indígenas Pemón y personas con discapacidad enfrentan las mayores barreras de movilidad para acceder a salud mental.



La precariedad económica y la desprotección en zonas rurales son los principales catalizadores del distrés emocional.



La falta de especialistas y psicofármacos en el sur de Bolívar convierte la salud mental en un privilegio geográfico y no en un derecho universal.



La brecha prestacional en el Nivel 4 (Especializado) es una emergencia de protección que requiere acción inmediata del EHP.

Recomendaciones de Acción Estratégica para Equipo Humanitario de País (EHP) y Clústeres Sectoriales

Financiamiento para el nivel de respuesta 4, atención especializada

Institucionalización de la Gestión de Información (GIH)

Incidencia con Enfoque de Género y Cuidados

Pertinencia Cultural y Adaptación Lingüística

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados durante la ejecución del proyecto .

